

العلامات الحيوية: قياس درجة الحرارة

الأهداف:

في نهاية المهارة سوف يكون الطلاب قادرين على:

- تطبيق التقنية الصحيحة لتقييم وتوثيق درجة الحرارة.

الغاية:

- للحصول على معلومات أولية للتقييم اللاحق.
- لتحديد التغيرات في درجة حرارة الجسم استجابةً لعلاجات خاصة.
- لمراقبة المرضى المعرضين لخطورة ارتفاع الحرارة.
- لمعرفة درجة حرارة المريض من أجل اجراء التدخل المناسب في حال ارتفاع أو انخفاض الحرارة

الأدوات:

- صينية مستطيلة تحتوي على:
 - أ- ميزان حرارة (فموي).
 - ب- ٣ كؤوس
 - ت- كرات قطن
 - ث- وعاء كلوي صغير عدد ٢
 - ج- محلول مطهر (كحول ٧٠ %)، و وعاء فيه صابون سائل.
 - ح- وعاء من الماء النظيف.
- أدوات إضافية للحرارة الإبطية:
 - منشفة \ محارم لتجفيف منطقة الإبط
- أدوات إضافية للحرارة الشرجية:
 - ميزان حرارة (شرجي)
 - مادة مزقة (جيل)
 - قفازات نبوذة
 - محارم ورقية
 - صحيفة تسجيل +قلم

الاجراء:

م	الخطوات	التبرير العلمي	مرضي	غير مرضي
١	حدد المريض	لتقديم العناية للمريض الصحيح		
٢	قيم المكان الذي سوف تأخذ منه درجة الحرارة	يساعد في تحديد المكان الأنسب لقياس الحرارة		
٣	اغسل يديك	للتقليل خطر انتقال العدوى		
٤	جمع الأدوات	للحفاظ على الوقت والطاقة		
٥	تفحص الأنبوب الزجاجي للميزان	الزئبق قد يتسرب من خلال الشقوق و الزجاج المنكسر وقد يسبب أذية		
٦	اشرح الاجراء للمريض	يقلل من خوف وقلق المريض ويكسب تعاونه		
٧	إذا كان الميزان في علبة: - اخرج الميزان من العلبة - اغسل الميزان بالماء والصابون من منطقة نهاية الميزان إلى خزان الزئبق في حركة فتل ثابتة. - اغسل الميزان بالماء النظيف من نهاية الميزان إلى خزان الزئبق في حركة فتل ثابتة - ضع الميزان بالمحلول المطهر لمدة ٥-١٠ د. وسجل وقت وضعه بالمحلول - أخرج الميزان من المحلول المطهر واغسله بالماء النظيف من منطقة خزان الزئبق إلى نهاية الميزان مستخدماً حركة فتل ثابتة. - جفف الميزان بقطع من القطن من منطقة خزان الزئبق إلى نهاية الميزان مستخدماً حركة فتل ثابتة.	- تنظيف الميزان وانقاص خطر العدوى - تنظيف الميزان من المنطقة الأقل تلوثاً إلى المنطقة الأكثر تلوثاً		
٨	إذا كان ميزان الحرارة في وعاء يحوي محلول مطهر: - خذ الميزان من المحلول المطهر واغسله بالماء النظيف من منطقة خزان الزئبق إلى نهاية الميزان. مستخدماً حركة فتل ثابتة.	- تنظيف الميزان وانقاص خطر العدوى - تنظيف الميزان من المنطقة الأقل		

		تلوثاً إلى المنطقة الأكثر تلوثاً	- امسح بقطعة قطن جافة من منطقة خزان الزئبق إلى نهاية الميزان مستخدماً حركة قتل ثابتة.	
٩		لقراءة دقيقة	اقرأ درجة الحرارة على الميزان في مستوى العين	
١٠		- الزئبق يجب أن يكون تحت ٣٥ درجة. قراءة ميزان الحرارة يجب أن تكون أقل من درجة الحرارة الفعلية للمريض قبل الاستعمال. - الرج الخفيف يخفض مستوالبزئبق	أخفض مستوى الزئبق إلى أقل من ٣٥ درجة من خلال رجه بشكل خفيف ومسكه بثبات	
م	الخطوات	التبرير العلمي	مرضي	غير مرضي
١١	(أ)	للتأكيد قراءة دقيقة - الميزان يحتاج ليعكس الحرارة الرئيسية للدم في الأوعية الدموية الكبيرة للجيب الخلفي للسان - لتأكيد صحة النتائج ومنع ميزان الحرارة من السقوط أو الانكسار - لتأكيد قراءة دقيقة - يقلل من احتمال كسر الميزان بأسنان المريض - لتأمين قراءة واضحة للحرارة. يتم المسح من المنطقة الأقل تلوثاً	الحرارة الفموية: أ- تأكد من أن المريض لم يتناول سوائل باردة أو ساخنة ولم يدخل لمدة لا تقل عن ١٥-١٠ دقيقة. ب- ضع الميزان تحت لسان المريض بزاوية ٤٥ درجة في وضعية تسمح لمنطقة الخزان أن تستقر على أحد جانبي لجام اللسان اللسان ت- أرشد المريض إلى: - إغلاق فمه بحذر مع شفتين ملتصقتين مع بعضهما - تجنب العض على ميزان الحرارة - الامتناع عن الكلام ث- اترك ميزان الحرارة في الفم لمدة ٣-٥ دقائق. ج- امسك الميزان بحذر، واطلب من المريض أن يفتح فمه ثم أخرج الميزان. ح- امسح أي مفرزات على الميزان بقطعة من القطن. امسح بطريقة دائرية من نهاية الميزان إلى منطقة الخزان. خ- اقرأ الميزان في مستوى العين (بتدوير بطيء للميزان والنظر إلى الخط الفضي على	

		إلى المنطقة الأكثر تلوثاً. - لتأكيد قراءة دقيقة.	طول الميزان)	
١١	(ب)	الحرارة الإبطية أ- اسدل الستائر حول سرير المريض أو أغلق الباب. ب- أزل ملابس المريض بعيداً عن كتفه و ذراعه. ت- تأكد من أن منطقة الإبط جافة ث- ضع الميزان في مركز الإبط، اخفض ذراع المريض فوق الميزان وضع الساعد فوق الصدر. ج- ثبت الذراع بلطف في مكانها (إذا تطلب الأمر ذلك) ح- اترك الميزان في مكانه لمدة ٥ دقائق على الأقل خ- أزل الميزان - امسح أي مفرزات على الميزان بقطعة من القطن. امسح بطريقة دائرية من نهاية الميزان إلى منطقة الخزان. وارفعه إلى مستوى العين ولاحظ القراءة د- أعد ثياب المريض كما كانت	- لتوفير الخصوصية و الراحة - يؤمن كشف مناسب لمنطقة الإبط. - تعتبر الرطوبة ناقل للحرارة وقد تؤدي إلى قراءة غير دقيقة - لوضع الميزان فوق الأوعية الدموية - الحركة ممكن أن تغير مكان الميزان وتعطي قراءة خاطئة ويمكن أن يقع وينكسر - لتأكيد قراءة دقيقة- لتأكيد قراءة دقيقة	
١٢		يعزز مشاركته في العناية وفهم حالته الصحية	أعلم المريض بدرجة الحرارة	
١٣			أ- اغسل الميزان بالماء والصابون من منطقة نهاية الميزان إلى خزان الزئبق في حركة فتل ثابتة. ب- اغسل الميزان بالماء النظيف من نهاية	

			الميزان إلى خزان الزئبق في حركة قتل ثابتة ج-جفف الميزان بقطع من القطن مستخدماً حركة القتل	
		لحمايته من الكسر لمعرفة مدة بقاءه في المحلول لاستخدامه مرة ثانية	أعد الميزان إلى العلبة / المحلول المطهر(سجل وقت وضعه في المحلول المطهر)	١٤
		يقلل من انتقال الميكروبات	اغسل يديك	١٥
		تأكيد استمرارية التواصل	وثق بشكل دقيق في سجل العلامات الحيوية اسم المريض والتاريخ و الوقت وقيمة الحرارة ومكان أخذ الحرارة واسمك وتوقيعك تبعاً لسياسة المشفى في التطبيق	١٦

(ملاحظات المدرس): الاجراء تم في مختبر المهارات أو على المريض أو في المجتمع.

سجل عدد المحاولات التي نفذها الطالب لانجاز حالة مرضية للمهارة.

اسم المدرس

التاريخ

التوقيع

قياس النبض

الأهداف :

في نهاية الإجراء سيكون الطلبة قادرين على :

- معرفة الهدف من أخذ النبض
- معرفة المعدل الطبيعي للنبض
- يشرح مستعيناً بالأمثلة التقنية الملائمة لقياس النبض

الغايات:

- توفير بيانات أساسية للمقارنة معها لاحقاً
- لمراقبة حالة القلب والأوعية الدموية وتحديد التغيرات
- لمراقبة المرضى المعرضين لخطر الإصابة بتغيرات في القلب والدوران
- لتقييم فعالية الأدوية والأنشطة على حالة القلب والدوران

الأدوات :

- ساعة ذات عقرب ثواني
- ورقة توثيق للعلامات الحيوية
- قلم (حبر أزرق ناشف)
- سماعة طبية
- قطن و كحول

الإجراء :

م	الخطوات	التبرير	مرضي	غير مرضي
١	حدد المريض الصحيح	لتقديم الرعاية للمريض الصحيح		
٢	اغسل يديك	للقاية من العدوى المتصالبة		
٣	حضر الأدوات	الوصول السهل للأدوات يمنع التأخير ويوفر الوقت والطاقة ويمنع النقطات أثناء الإجراء		
٤	اشرح الإجراء للمريض	لكسب التعاون والتقليل من قلق المريض		
٥	قيم أي نشاط قام به المريض قبل فحص النبض	المريض الذي قام بجهد سيحتاج للراحة لبضع دقائق للسماح بعودة النبض إلى الوضع الطبيعي		
٦	ضع المريض في وضعية مريحة أرج ذراع المريض على طول جانب الجسم مع مد الرسغ وراحة اليد للأعلى أو الدا خل يمكن للمريض أن يضع ساعده بزاوية ٩٠ درجة مع الجسم مستريحاً على مسند والرسغ ممدود والراحة	الوضعية المسترخية للذراع السفلي وبسط الرسغ يسمح بكشف كامل للشريان من أجل الجس		
٧	ضع رؤوس أول أصبعين أو ثلاثة أصابع (الوسطى) لليد المسيطرة فوق التلم على طول الشريان الكعبري أو جانب الإبهام للرسغ الداخلي للمريض	رؤوس الأصابع أكثر أجزاء اليد حساسية للنبض الشرياني. في الإبهام هناك نبض وذلك قد يتعارض مع الدقة لذلك لايجس النبض الشرياني بالإبهام		
٨	اضغط بلطف الشريان الكعبري، جس	النبض يقاس بدقة أكثر عندما يكو الضغط		

		متوسط. الضغط الشديد يحبس النبض ويضعف جريان الدم	النبض أولاً ثم خفف الضغط بحيث يصبح النبض مجسوساً بسهولة.	
٩		من الضروري توفير الوقت الكافي لتقييم معدل النبض و ، نظمه ، وامتلاءه	باستعمال ساعة مزودة بعقرب ثواني ، عد النبضات خلال دقيقة	
١٠		عدم الإنتظام معدل القلب قد يعطل نتاج القلب. سعة النبض تشير إلى جودة تقلصات القلب	قيم النبض ، النظم ، القوة والامتلاء ،بينما تقوم بعد النبض	
م	الخطوات	التبرير	مرضي	غير مرضي
		لمنع انتقال العدوى	لتقييم نبض القمة : أ- ضع المريض بوضعية مناسبة ب- أغلق الأبواب وأسدل الستائر ت- نظف السماعه(قطعتي الأذنين و حجاب السماعه) بمحلول مطهر وتأكد من صلاحيتها ث- ساعد المريض على خلع ثيابه التي فوق الصدر مع الحفاظ على خصوصيته ج- حدد مكان نبض القمة : نقطة نبض القمة هي نقطة تقاطع الخط الناصف للترقوة مع الورب الخامس عند البالغين ح- دفي حجاب السماعه وضعه فوق نقطة نبض القمة وأصغي لمدة دقيقة كاملة خ- ساعد المريض ليرتدي ثيابه	
		لمنع العدوى المتصالبة	اغسل يديك	١١
		يعزز استمرارية العناية	وثق الإجراء – سجل النبض في صحيفة العلامات الحيوية - مكان أخذ النبض - معدل النبض ، النظم ، القوة - أي موجودات غير طبيعية متعلقة بالنبض • <u>قيم الأنباض المحيطية التالية :</u> • النبض الصدغي • السباتي • العضدي • الكعبري • الفخذي • الطنبوبي الخلفي • ظهر القدم • المأبضي	١٢

تعليق المدرس : يؤدي في مختبر المهارات أو على المريض أو ضمن المجتمع

إذا سمحت سجل عدد المحاولات التي قام بها الطالب قبل الوصول الى انجاز مرض للمهارة

التاريخ

اسم المدرس و توقيعه:

العلامات الحيوية: قياس التنفس

الأهداف:

في نهاية هذه المهارة سوف يكون الطلاب قادرين على :

- توضيح الغاية من أخذ التنفس.
- تطبيق التقنية الصحيحة لقياس التنفس.

الغاية:

- الحصول على المعطيات الأساسية للمقارنة معها لاحقاً
- مراقبة الحالة التنفسية غير الطبيعية وتحديد التغيرات
- مراقبة المرضى المعرضين لخطر التغيرات في التنفس
- تقويم تأثير الأدوية و النشاط على الحالة التنفسية

الأدوات:

- ساعة ذات عقرب ثواني
- صحيفة تسجيل للعلامات الحيوية
- قلم (أسود)

الإجراء:

م	الخطوات	التبرير العلمي	مرضي	غير مرضي
١	حدد المريض	لتقديم العناية للمريض الصحيح		
٢	اغسل يديك	منع خطر إنتقال العدوى		
٣	جمع الأدوات	الوصول السهل ومنع التأخير وحفاظاً على الوقت والطاقة و منع المقاطعة أثناء الاجراء		
٤	كن متأكداً من أن صدر المريض مرئي وقم بإزالة غطاء المريض أولباس المريض (إن لزم الأمر)			
٥	قيم أي نشاط قام به المريض قبل فحص التنفس	المريض الذي قام بجهد سيحتاج للراحة لبضع دقائق للسماح بعودة التنفس إلى الوضع الطبيعي		
٦	ضع المريض في وضعية مريحة			

م	الخطوات	التبرير العلمي	مرضي	غير مرضي
٧	- ضع يدك على صدر المريض لتشعر بحركة الصدر أو ضع ساعد المريض على الصدر. - لاحظ حركة الصدر بينما أنت تتظاهر بأنك تقيس في نفس الوقت النبض الكعبري.	- إدراك المريض بأنك تقيس له التنفس سيتسبب في مشاركة المريض بشكل طوعي ليغير نموذج تنفسه		
٨	افحص معدل التنفس، النظم، والعمق لمدة دقيقة واحدة	للحفاظ على دقة القراءة		
٩	اغسل يديك	منع خطر إنتقال العدوى		
١٠	وثق الإجراء على صحيفة تسجيل العلامات الحيوية وفقا لسياسة المشفى. وثق التالي في الملاحظات التمريضية: - نظم التنفس وعمقه - التاريخ والوقت - أي موجودات غير طبيعية متعلقة بالتنفس	• لتعزيز استمرار العناية والمعالجة		

(ملاحظات المدرس): الاجراء تم في مختبر المهارات أو على المريض أو في المجتمع.

سجل عدد المحاولات التي نفذها الطالب لانجاز حالة مرضية للمهارة.

اسم المدرس

التاريخ

التوقيع

قياس ضغط الدم الشرياني

الأهداف :

في نهاية المهارة سوف يكون الطلاب قادرين على :

- توضيح السبب المنطقي لقياس ضغط الدم.
- توضيح معلومات حول العوامل التي تؤثر على قراءة ضغط الدم
- معرفة التقنية الصحيحة لتقييم وتوثيق ضغط الدم

الغاية:

- للحصول على معطيات أساسية للمقارنة معها لاحقاً
- تقييم الحالة الديناميكية (حركة الدم ، مقاومة الشرايين)
- مراقبة استجابة الجهاز الدوراني للحالات المرضية المختلفة والمعالجات أيضاً

الأدوات :

- جهاز لقياس الضغط الدموي
- كم بحجم مناسب
- سماعة طبية
- قطن مبلل بالكحول
- صحيفة تسجيل
- قلم أسود

الإجراء :

م	الخطوات	التبرير	S مرضي	U غير مرضي
١	حدد المريض	للعناية بالمريض الصحيح		
٢	اشرح الإجراء للمريض	لتقليل قلق المريض وكسب تعاونه		
٣	قيم أي نشاط قام به المريض قبل فحص الضغط	المريض الذي قام بجهد سيحتاج للراحة لبضع دقائق للسماح بعودة الضغط إلى الوضع الطبيعي		
٤	اغسل يديك	منع انتقال العدوى		
٥	جهز الأدوات وتأكد من صلاحية جهاز الضغط	لتوفير الوقت والطاقة والتأكد من وظيفة الجهاز		
٦	نظف قطعتي الأذن وحجاب السماعة بقطن مبلل بالكحول	لمنع انتقال الأحياء الدقيقة		
٧	ضع قطعتي الأذن للسماعة على أذنيك وافحص طبلة السماعة بالنقر عليها	النقر لفحص سماع الصوت		
٨	ضع المريض في وضعية الجلوس أو الاستلقاء الظهرى	- يعزز راحة المريض واسترخائه - يزود بقراءة دقيقة		
٩	تأكد من أن مقياس الضغط موضوع بشكل عمودي على مستوى العين	للحصول على قراءة دقيقة لمستوى الزئبق		
١٠	ثبت ساعد المريض على مستوى القلب مع راحة يد متجهة للأعلى	- يزداد ضغط الدم عندما يكون الساعد تحت مستوى القلب		

		- يقل ضغط الدم عندما يكون الساعد أعلى من مستوى القلب	
١١	اكتشف أعلى ذراع المريض اليسرى بإزالة الألبسة الموجودة	- لتأمين تطبيق ملائم لكم الجهاز - لف الكم للداخل بسبب قراءة غير دقيقة	
١٢	لف الكم المفرغ من الهواء بشكل سوي حول الذراع العلوي بوضع الحافة السفلية للكم ٢,٥ سم فوق الحفرة المرفقية. تأكد أن الجيب موجود فوق الجهة المتوسطة لأعلى الذراع	- لف الكم بشكل سوي ينتج عنه ضغط صحيح - الكم المرتخي/شديد الاحكام يعطي قراءة خاطئة - الجيب فوق الشريان العضدي يعطي قراءة دقيقة	
١٣	-تأكد من إغلاق عمود الزئبق في مقياس الضغط الزئبقي قبل ملء الكم بالهواء تأكد من إغلاق صمام الجهاز		
١٤	حدد مكان الشريان العضدي وضع طبلبة (حجاب) السماعه فوق النبض العضدي. لاتدع طبلبة السماعه تلمس كم جهاز الضغط أو لباس المريض	- الوضع الصحيح للسماعة يحقق استقبال صوت أفضل - الوضع غير الصحيح للطبلبة يسبب سماع أصوات خافتة غير واضحة، وغالباً ما يتسبب في قراءة ضغط انقباضي منخفض وضغط انبساطي مرتفع	
١٥	انفخ الكم إلى ٣٠ ملم ز فوق مكان اختفاء النبض	يعطي قياس دقيق للضغط الانقباضي	
١٦	حرر الصمام ببطء و اسمح للزئبق بالنزول بمعدل ٢-٣ مم ز بالثانية	إنزال الزئبق بسرعة أو ببطء شديد يعطي قراءة غير دقيقة	
١٧	لاحظ القراءة في جهاز قياس الضغط حيث أول صوت واضح يسمع	أول صوت من أصوات كورتوكوف يشير إلى الضغط الانقباضي	
١٨	استمر في إفراغ الكم بالتدريج ملاحظاً القيمة حيث يختفي الصوت	تشير إلى الضغط الانبساطي	
١٩	افرج الكم بسرعة وكلياً. أبعد الكم عن ذراع المريض. أقل عمود الزئبق إلا إذا كنت تريد إعادة قياس الضغط .	لمنع انسداد الشريان الذي ينتج عنه خدر وشعور بوخز خفيف في ذراع المريض	
٢٠	ساعد المريض لاتخاذ الوضعية المريحة وغط أعلى الذراع	لتأمين راحة المريض	
٢١	أعلم المريض بقراءة ضغط الدم (بالاعتماد على حالة المريض)	يعزز مشاركة المريض في العناية والفهم للحالات الصحية	
٢٢	نظف السماعه بالقطن المبلل بالكحول وأعد الأدوات للمكان المناسب	يؤمن حماية للأدوات ويمنع انتشار البكتريا	
٢٣	اغسل يديك	للتقليل من انتشار العدوى	
٢٤	وثق الإجراء – وسجل بدقة على صحيفة التسجيل التاريخ و الوقت و قيمة الضغط والذراع التي تم قياس الضغط منها تبعاً لسياسة المشفى	التوثيق المباشر يسمح بالتدخل العلاجي الملائم عند الحاجة	

ملاحظات المدرب :

اسم المدرب وتوقيعه : ----- التاريخ : / /